2026 대한가정의학회 추계학술대회 발표 자료동료 연구자를 위한 안내
Research workflow · 2026

AI와 함께
논문 쓰고
발표하기

한 폴더 · 일곱 스킬 · 여덟 단계
국민건강영양조사 데이터로 하는 연구를 위한 실전 워크플로

김현수 · 가정의학과약 20분github.com/kimhs950627/ai-research-copilot

먼저 드릴 말씀

결과보다 오래 남는 것은 *과정*입니다

2026년 7월부터 10월까지, 저는 논문 한 편과 발표 하나를 만들었습니다.

그 과정에서 쓴 **폴더·프롬프트·검증 순서**를 그대로 남겼습니다. 여러분의 데이터는 이미지가 아니라 표이지만, 일하는 방식은 같습니다.

연구는 절반,
문서와 발표가 나머지 절반입니다

연구·분석가장 중요한 일
원고·표·그림반복·형식의 일
발표 준비마감 직전에 몰림

AI가 줄여 주는 것은 **아래 두 줄**입니다. 연구 자체가 빨라지지는 않습니다.

저자의 체감 비중이며, 측정된 연구 자료가 아닙니다.

오해부터 풉니다

챗봇은 말하고,
에이전트는 파일을 고칩니다

챗봇

- 복사 → 붙여넣기 → 다시 복사
- 파일을 볼 수 없음
- 결과가 내 컴퓨터에 남지 않음

에이전트 (OpenCode)

- 폴더를 열면 파일을 읽고 고침
- 코드를 실행해 표·그림 생성

핵심 차이는 “대화가 결과물”이 아니라 “폴더가 결과물”이라는 점입니다.

전체 지도

질문에서 큐카드까지,
여덟 단계

01질문을 계약서로
02자료·문헌 한곳에
03분석 계획 고정
04표 1 · 주 분석
05원고 IMRaD
06자체 심사
07투고 패키지
08발표 · 큐카드

3단계를 건너뛰면, 표가 나온 뒤에 질문을 바꾸게 됩니다.

스킬은 프롬프트가 아니라 절차서입니다

스킬	하는 일	부르는 때
academic-research-writing	원고·근거 장부·인용 검증	문헌고찰, IMRaD
deep-research	조사·비교·팩트체크	배경, 가이드라인
paper-review	제출 전 자체 심사	투고 1주 전
design-craft	색·타이포·여백·검사	PDF·포스터
deck-craft	16:9 덱·노트·PPTX	학회 발표
script-to-cuecards	대본 → 인쇄용 카드	리허설
clinical-prescribing-safety	처방·금기·상호작용	임상 질문

Step 1 · 질문

“알아보고자 했다”는 질문이 아닙니다

P40세 이상 성인
I복부비만
C복부비만 없음
O대사증후군

“국민건강영양조사에서 40세 이상 성인의 복부비만과
대사증후군의 연도별 연관은 어떠한가?”

질문·설계·주 결과·보고 지침을 `notes/decision.md`에 10줄로 적으면 1단계 끝.

1단계07 / 17

가중치를 빼면
그 숫자는 한국의 값이 아닙니다

- 층 `kstrata` · 집락 `psu` · 가중치 `wt_itvex`
- 가중치를 빼면 젊은 층이 과대표
- 층·집락을 빼면 **p값이 실제보다 작아짐**
- 2024년엔 `wt_exam`이 **없음**

R · survey

```
des <- svydesign(
  ids = ~psu, strata = ~kstrata,
  weights = ~wt_itvex,
  nest = TRUE, data = raw)
```

매 프롬프트에 붙이세요: **“복합표본설계를 반영하고, 변수명은 코드북에서 확인해.”**

2024(9기 3차년도) 코드북 p.94 기준. 영양 변수를 더하면 wt_tot.

표가 먼저,
문장은 나중입니다

나쁜 문장

“복부비만군에서 대사증후군 유병률이 42.3%로 비복부비만군의 21.7%보다 유의하게 높았다(p<0.001).”

좋은 문장

“복부비만군에서 대사증후군 유병률이 더 높았으며, 추정치는 표 2에 제시하였다.”

문장 하나에 숫자는 최대 하나. 나머지는 **표를 가리킵니다.**

Step 6 · 제출 전

심사자를 먼저 부릅니다

HIGH

- 근거 없는 단정
- 표에 없는 숫자
- 존재하지 않는 인용

MED

- 숫자 나열 문단
- 표·그림 번호 불일치

고치게 하지 말고, 먼저 **지적**하게 합니다.

자체심사10 / 17

제출 화면에서
헤매지 않으려면

```
04_manuscript/submission/
├── 01_title_page.docx
├── 02_manuscript_blind.docx
├── 03_tables.docx
├── 04_figures/
├── 05_cover_letter.docx
└── 06_coi_ai_statement.docx
```

- 맹검판·비맹검판 따로
- 표·그림은 별도 파일
- AI 사용 공개 문구
- 빠진 파일은 “없음”으로 표시

Step 8 · 발표

8분은 13장입니다

30–45슬라이드당 초
11–148분 권장 장수
±10%리허설 허용 오차

장수를 늘리는 것보다 **한 장을 오래 보는 편**이 낫습니다. 제 발표는 13장·7분 35초였습니다.

발표12 / 17

말할 문장과
손에 들 것을 따로 만듭니다

01아웃라인 — 제목 = 주장
02덱 — 한 장에 한 아이디어
03대본 — 시간 붙이기
04큐카드 — A4 두 장 분할
05리허설 — 타이머 3회

큐카드는 대본을 **줄이지 않습니다.** 넘치면 “계속” 카드로 이어 붙입니다.

큐카드13 / 17

이기지 못한 결과를
어떻게 발표했나

95.71민감도 %
100특이도 %
0.125McNemar p
13슬라이드

“차이는 유의하지 않습니다. 다만 **실패하는 지점이 다릅니다.**”

한계를 먼저 말한 슬라이드가 심사위원의 신뢰를 만들었습니다.

테스트 268장 · 134/0/6/128 · 정확도 97.76% · 단일 기관 공개 데이터셋.

심사 발표를 앞두고

심사위원은 통계보다
다음 질문을 합니다

Q1

IRB는 통과했나요?

승인번호·면제 사유를 30초로. “필요 없었어요”가 아니라 “이 근거로 면제받았습니다”.

Q2

계속 연구할 건가요?

1년 계획 2문장. “네”보다 “외부 검증 → 전향 코호트 → 다기관”.

Q3

임상에서 어디에 쓰나요?

판독 대체가 아니라 **워크플로의 한 칸**을 지정.

심사위원이 자주 묻는 질문 유형.
심사대비15 / 17

국민건강영양조사 2차 분석만으로는 독창성을 보이기 어렵습니다

데이터	강점	약점	설득 전략
원내 후향 코호트	우리 기관만의 데이터	선택 편향·결측	코호트 구축 자체를 기여로
공개 데이터셋	재현·벤치마크	외부 타당도	방법론 + 외부 검증 계획
국민건강영양조사	전국 대표성	독창성 약함	정책·추세 + 다른 자료 연결

좋은 평가를 받는 두 갈래: 검진센터 *H. pylori* 후향 코호트, 그리고 공개 데이터셋 연구.

오늘 저녁, 세 가지

완주가 아니라
첫 표 하나가 목표입니다

1. **01**OpenCode를 설치하고 폴더 하나를 연다
2. **02**`@academic-research-writing`을 불러 본다
3. **03**내 초록을 넣고 “문제 3개만 짚어줘”라고 한다

감사합니다. 질문은 지금 받겠습니다.

github.com/kimhs950627/ai-research-copilot · guide/index.html